PRÓTESIS REVERSA DE HOMBRO

TÉCNICA QUIRÚRGICA - VÁSTAGO CORTO



SISTEMA DE ARTROPLASTIA REVERSA DE HOMBRO

ÍNDICE

01	Introducción, indicaciones y planificación	3
02	Preparación de la diáfisis humeral	4
03	Preparación glenoidea e implantación de la base	6
04	Preparación de la metáfisis humeral	10
05	Implantación de la glenosfera	13
06	Implante humeral	15
07	Retirada y revisión	17
08	Nomenclatura de implantes e instrumentos	20
09	Compatibilidad y codificación por colores	24
10	Notas y esterilización	25
11	Aviso profesional	27
12	Trazabilidad documental	28

Medacta International

INTRODUCCIÓN Y PLANIFICACIÓN

1. INTRODUCCIÓN

Esta técnica describe la artroplastia total reversa de hombro con vástago corto y base glenoidea con perno central. La selección del implante y cada maniobra deben ajustarse a la anatomía, calidad ósea y planificación del paciente.

1.1 INDICACIONES

- Fracturas del húmero que requieran reconstrucción protésica.
- Artroplastia total primaria o de revisión con insuficiencia marcada del manguito rotador.
- Artropatía grave o reemplazo articular previo fallido asociado a deficiencia marcada del manguito rotador.
- Articulación anatómica y estructuralmente apta para los componentes seleccionados, con músculo deltoides funcional.
- La base glenoidea se implanta sin cemento y se complementa con tornillos para obtener estabilidad primaria.

1.2 CONTRAINDICACIONES

- Infección local o sistémica, o sepsis.
- Calidad ósea insuficiente que pueda comprometer la estabilidad del implante.
- Deficiencias musculares, neurológicas o vasculares que comprometan la extremidad.
- Enfermedad concomitante o dependencia que pueda afectar la prótesis implantada.
- Sensibilidad o alergia a los materiales del implante.
- Pérdida de estructuras ligamentarias que impida estabilizar el dispositivo o mantener su función in vivo.
- Músculo deltoides no funcional.

1.3 PLANIFICACIÓN PREOPERATORIA

Realizar radiografías anteroposteriores en rotación interna y externa, proyección axilar y proyección de Morrison o Bernageau. En fracturas se recomienda TC con reconstrucción tridimensional. La RM puede aportar información sobre déficit óseo y calidad muscular/capsular, especialmente en artrosis y osteonecrosis. Considerar evaluación neurológica en cuadros postraumáticos. Las plantillas radiográficas de referencia tienen una escala del 115 %.

1.4 ABORDAJE QUIRÚRGICO

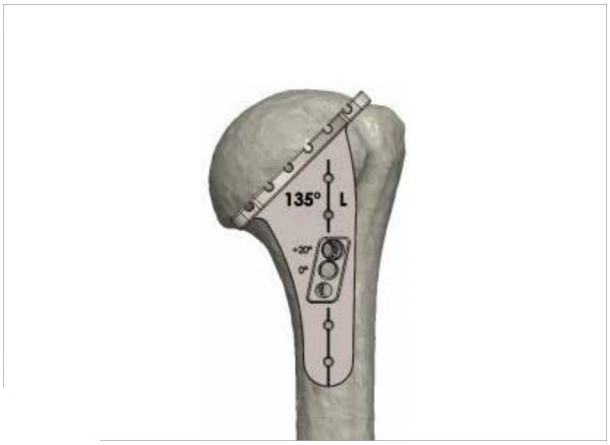
- Colocar habitualmente al paciente en posición de silla de playa y mantener espacio para extensión y aducción del hombro.
- Puede utilizarse abordaje deltopectoral o separación del deltoides; el instrumental está optimizado para el abordaje deltopectoral.
- Seguir el surco deltopectoral con una incisión habitual de 10-15 cm, adaptada al paciente y a la necesidad quirúrgica.
- Identificar la vena cefálica en el intervalo deltopectoral y movilizarla medial o lateralmente según preferencia y anatomía.
- Retraer el deltoides lateralmente y el pectoral mayor medialmente. Proteger el nervio musculocutáneo al retraer el tendón conjunto.
- Exponer el subescapular, liberarlo según necesidad y abrir la cápsula. Exponer la cabeza humeral con extensión, rotación externa y aducción.

Medacta International

2. PREPARACIÓN DE LA DIÁFISIS HUMERAL

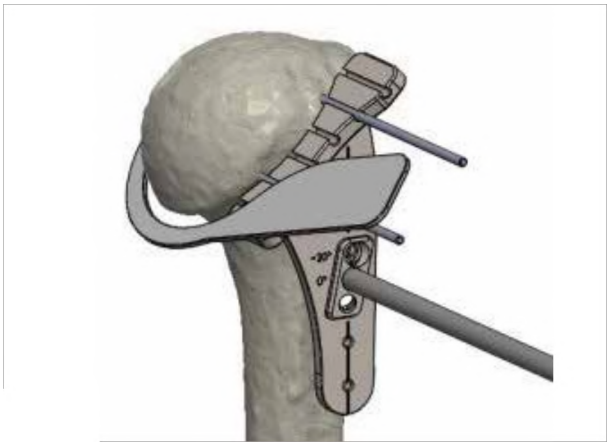
PASO 01 | Guía de corte humeral

Exponer la inserción medial del supraespinoso, la corredera bicipital y el cuello anatómico estimado. Posicionar la guía extramedular alineada con la diáfisis para obtener un corte aproximado de 135°.



PASO 02 | Control y resección

Comprobar inclinación y retroversión con la hoz humeral y la varilla de retroversión. Fijar la guía con dos pines de Ø2 mm y efectuar la resección con sierra oscilante.



PASO 03 | Apertura del canal humeral

Conectar el mango en T al abridor del canal medular. Iniciar la apertura 8 mm por detrás del punto más profundo de la corredera bicipital y próxima a la inserción medial del supraespinoso.



PASO 04 | Montaje de la raspa

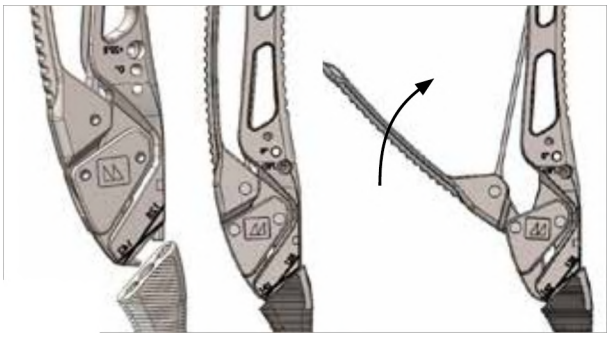
Retirar hueso esponjoso metafisario proximal para evitar infradimensionamiento o varo. Montar la raspa tamaño 6, cerrar la palanca y colocar la varilla en el orificio de 0° o 20°, alineada con el antebrazo a 90°.



2. PREPARACIÓN DE LA DIÁFISIS HUMERAL

PASO 05 | Raspado progresivo

Impactar suavemente la raspa hasta alinear su plano superior con la resección. Continuar con tamaños progresivos, manteniendo el eje y la retroversión previstos.



PASO 06 | Determinación del tamaño

El mayor tamaño cuya porción proximal quede completamente asentada en el canal determina el tamaño definitivo del vástago.



PASO 07 | Protección del corte

Elegir el protector que cubra mejor el plano de resección y fijarlo a la raspa con el destornillador HEX 3.5.

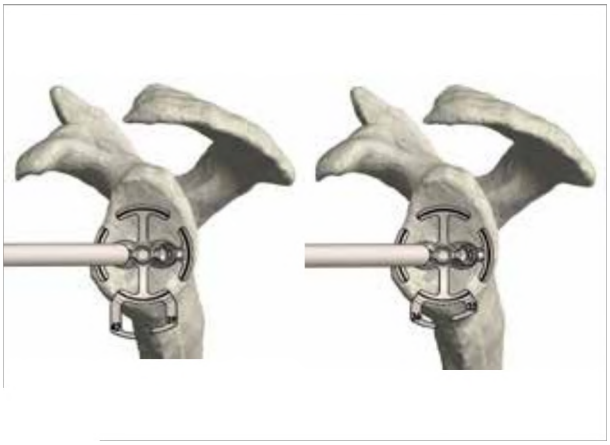


Medacta International

3. PREPARACIÓN GLENOIDEA Y BASE GLENOIDEA

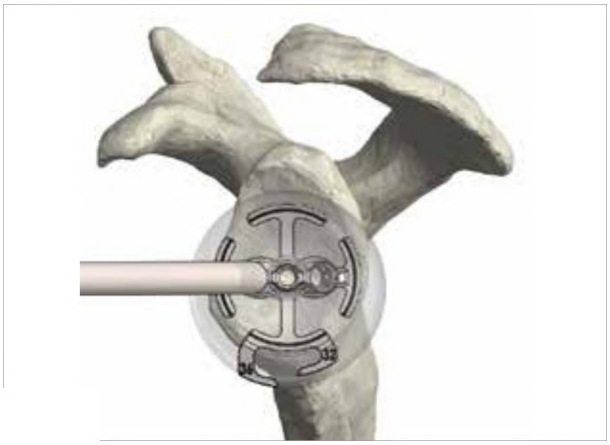
PASO 08 | Exposición de la glena

Resecar osteofitos antes de orientar la aguja. Exponer mediante rotación externa y abducción con liberación anteroinferior, o mediante flexión, rotación interna y leve abducción con liberación circunferencial.



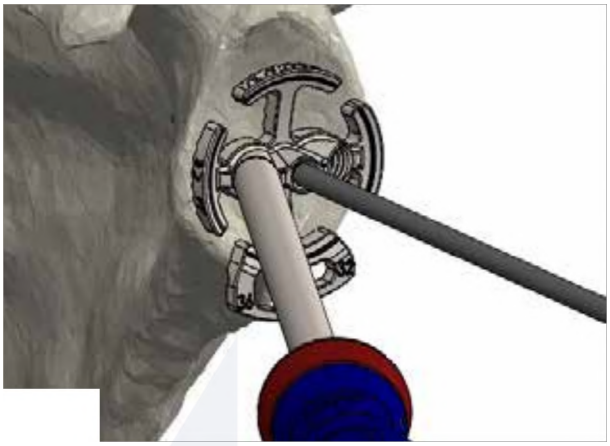
PASO 09 | Centro y tamaño glenoideo

Conectar la guía reversa al mango multipropósito y apoyarla sobre la bóveda glenoidea. La línea negra representa base Ø24,5 mm; los bordes externo e interno, Ø27 y Ø22 mm. Las patas inferiores indican el perfil de glenosferas.



PASO 10 | Colocación de la aguja guía

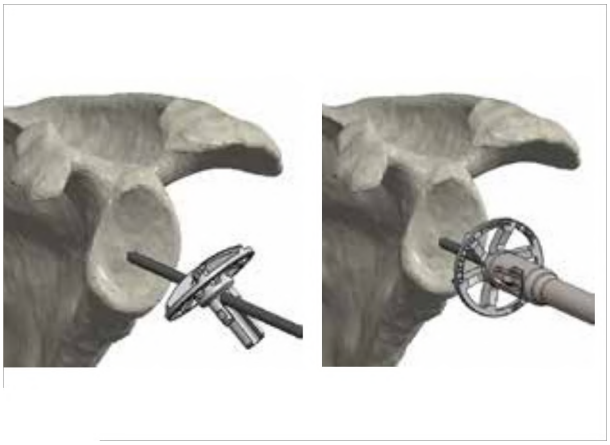
Definidos el centro, la base y la glenosfera, introducir la aguja de Kirschner de Ø2,5 mm por el orificio central con la orientación planificada. Retirar la guía y dejar la aguja colocada.



3. PREPARACIÓN GLENOIDEA Y BASE GLENOIDEA

PASO 11 | Montaje de la fresa glenoidea

Seleccionar la fresa del tamaño planificado, deslizarla sobre la aguja de Kirschner y conectarla al mango de fresado. Confirmar visualmente el diámetro final de la base.



PASO 12 | Fresado de la glena

Fresar con motor hasta la profundidad prevista, normalizando la versión sin adelgazar en exceso la placa subcondral.



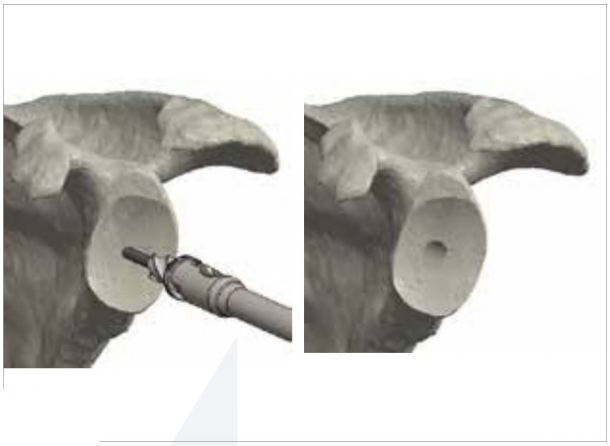
PASO 13 | Fresado periférico

Si se desea, comprobar el tamaño con una glenosfera de prueba. Montar la fresa periférica correspondiente y fresar manualmente sobre la aguja hasta obtener una superficie plana alrededor de la base y alcanzar el tope mecánico.



PASO 14 | Orificio central

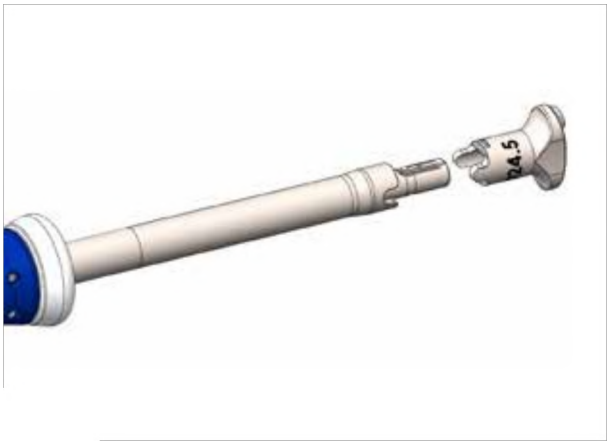
Seleccionar la longitud del fresador del perno central, montarlo en el mango y avanzar con motor sobre la aguja hasta el tope mecánico. Retirar la aguja.



3. PREPARACIÓN GLENOIDEA Y BASE GLENOIDEA

PASO 15 | Selección del impactor

Seleccionar la base glenoidea y conectar al mango la punta de impactación del diámetro correspondiente.



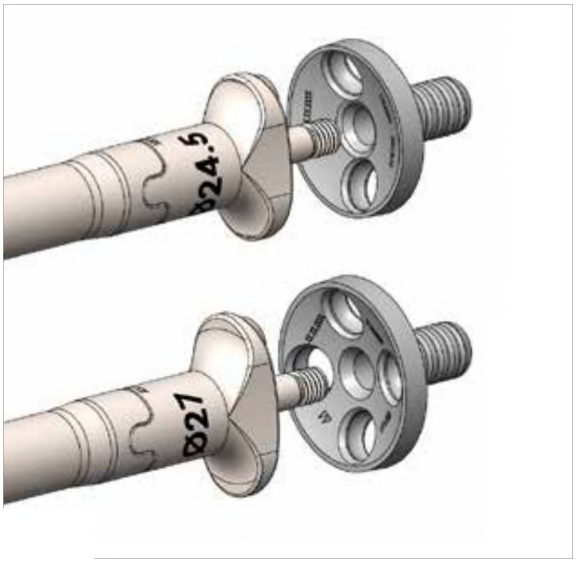
PASO 16 | Varilla de fijación M5

Deslizar la varilla de fijación M5 dentro del impactor ensamblado.



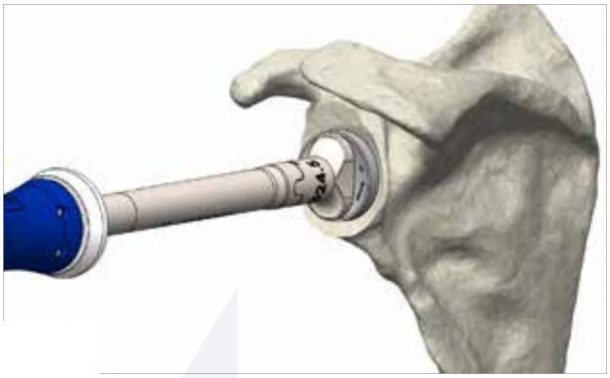
PASO 17 | Fijación de la base

Enroscar la varilla hasta sujetar firmemente la base glenoidea al impactor.



PASO 18 | Impactación de la base

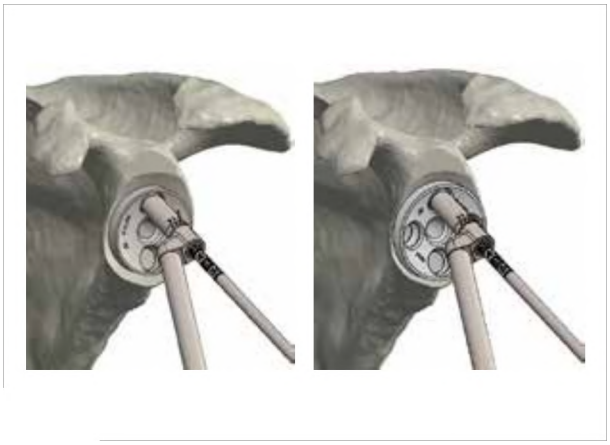
Orientar los dos orificios para tornillos en dirección inferosuperior, usando las marcas del impactor. Impactar la base hasta alcanzar el tope completo.



3. PREPARACIÓN GLENOIDEA Y BASE GLENOIDEA

PASO 19 | Perforación para tornillos

Insertar la guía en cada asiento esférico y orientar dentro de un cono de 15°. Perforar a la profundidad prevista y comprobarla con las marcas o el profundímetro. Los tornillos superior e inferior son obligatorios; anterior y posterior, opcionales y solo disponibles en la base Ø27 mm.



PASO 20 | Conexión del tornillo

Seleccionar la longitud medida. Montar la punta modular del destornillador poliaxial en el mango y conectarla a la cabeza del tornillo.



PASO 21 | Inserción del tornillo

Introducir el tornillo hasta que la punta modular se desacople de la cabeza y asentar completamente la cabeza con el destornillador poliaxial.



PASO 22 | Bloqueo poliaxial

Montar la punta T10 en el destornillador limitador de 2 N.m y apretar el tornillo interno hasta que el limitador deslice. Repetir en cada tornillo.



3. PREPARACIÓN GLENOIDEA Y BASE GLENOIDEA

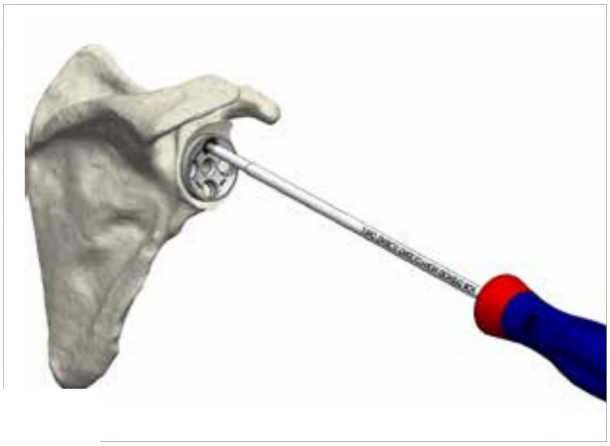
PASO 23 | Tornillo no bloqueado

Como alternativa, conectar el tornillo poliaxial no bloqueado al destornillador T15, introducirlo en el hueso y asentar su cabeza en la base.



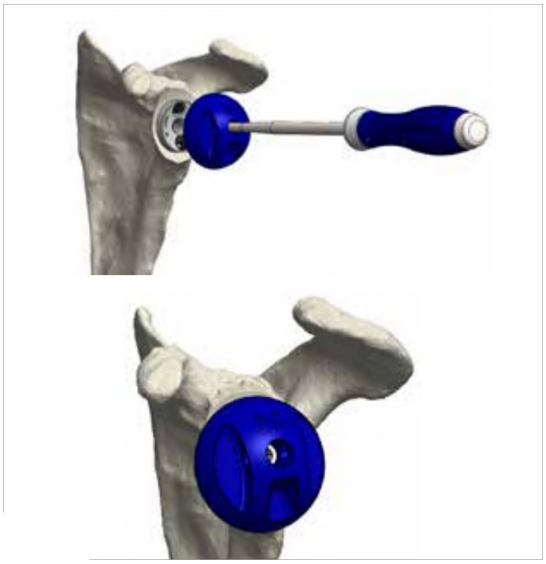
PASO 24 | Compresión definitiva

Repetir la inserción de los tornillos seleccionados hasta que la base glenoidea quede completamente comprimida contra la bóveda preparada.



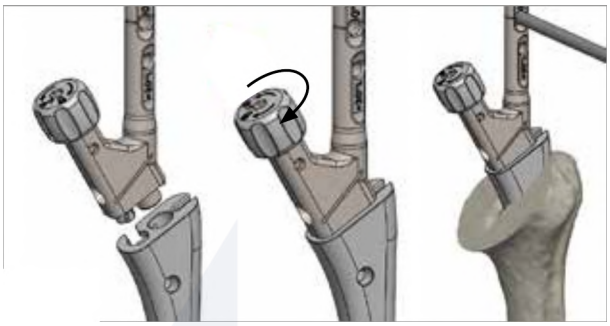
PASO 25 | Prueba de glenosfera

Introducir la glenosfera de prueba más grande compatible, orientarla con pinza y bloquear su tornillo. Si se requiere mayor lateralización, utilizar una opción aumentada que desplace 5 mm el centro de rotación.



PASO 26 | Prueba diafisaria

Retirar protector y raspa. Conectar la diáfisis de prueba del mismo tamaño, insertarla hasta que la línea quede al ras de la resección y controlar 0° o 20° con el antebrazo a 90°. Desbloquear y retirar el inserter.



4. PREPARACIÓN DE LA METÁFISIS HUMERAL

PASO 27 | Fresado humeral

Conectar la guía de fresado a la diáfisis de prueba. Montar la fresa metafisaria reversa, deslizarla sobre la guía y fresar con motor hasta el tope mecánico.



PASO 28 | Prueba metafisaria

Conectar la metáfisis reversa de prueba a la diáfisis y fijarla con el tornillo integrado.

ADVERTENCIA: La orientación es correcta cuando la marca MEDIAL apunta al cálcar y el pin de indexación queda lateral.



PASO 29 | Prueba del inserto reverso

Insertar el inserto del diámetro de la glenosfera. Alinear la marca medial para 155° o girarlo 180° para 145°. Reducir y comprobar estabilidad y movilidad. Alturas: metáfisis +0 con insertos +0/+3/+6; metáfisis +9 con insertos +0/+3/+6 produce +9/+12/+15 mm. Hay correcciones de 20° derecha/izquierda.

ADVERTENCIA: Descartar choque glenohumeral precoz o apertura en bisagra durante aducción, extensión y rotaciones.

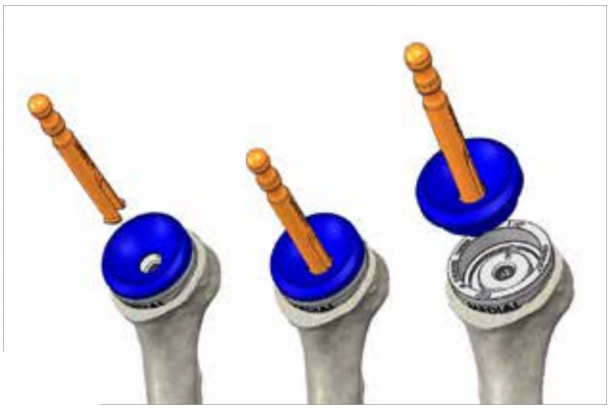


Medacta International

4. PREPARACIÓN DE LA METÁFISIS HUMERAL

PASO 30 | Registro y retirada del inserto

Registrar altura e inclinación del inserto, y altura y retroversión de la metáfisis. Acoplar el extractor al inserto de prueba y tirar para retirarlo.



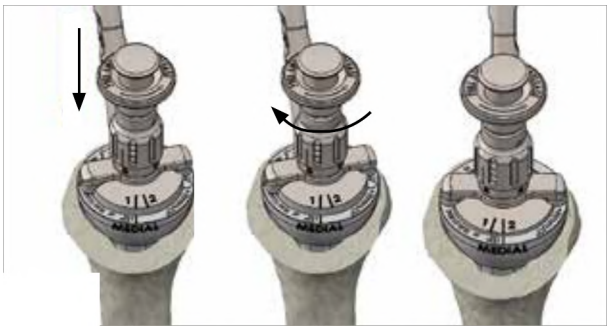
PASO 31 | Conexión del inserter humeral

Deslizar el inserter del vástago reverso dentro de la metáfisis de prueba, alineando la marca 1 del instrumento con la línea medial del implante.



PASO 32 | Retirada de los componentes de prueba

Presionar el mango y girar en sentido horario hasta alinear la marca 2 y percibir el encastre. Extraer el vástago de prueba. Liberar pasando de 2 a 1. Registrar tamaño/orientación y retirar la glenosfera de prueba.



5. IMPLANTACIÓN DE LA GLENOSFERA

PASO 33 | Guía de glenosfera

Conectar la guía de glenosfera a la punta retentiva del destornillador HEX 3.5 y enroscarla en la base.



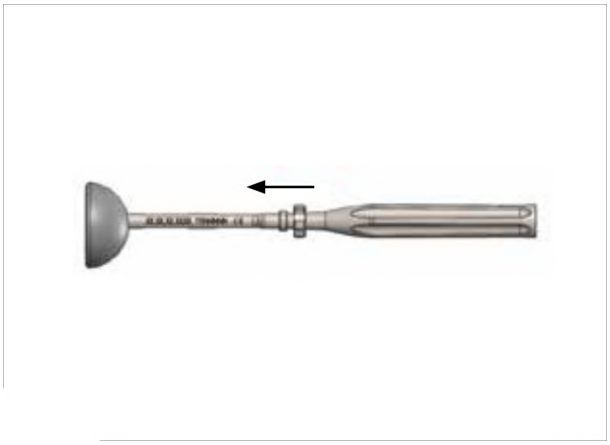
PASO 34 | Posicionador de glenosfera

Enroscar el posicionador a la glenosfera definitiva seleccionada.



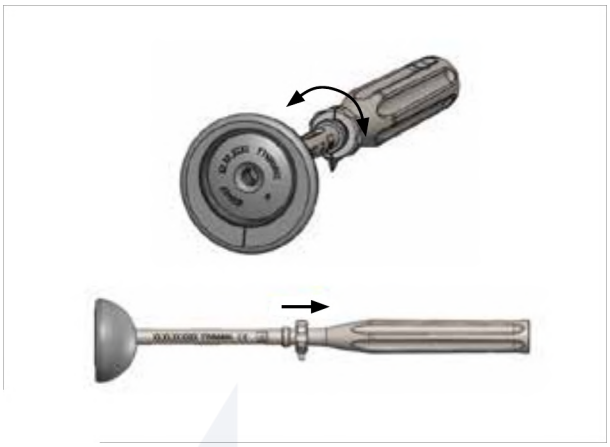
PASO 35 | Puntero de excentricidad

Empujar el puntero de excentricidad hacia la glenosfera para liberarlo.



PASO 36 | Bloqueo de la excentricidad

Alinear el puntero con la línea marcada en la superficie posterior de la glenosfera y tirar hacia atrás para fijar la orientación. Presentar el componente sobre la base guiando ambos elementos.

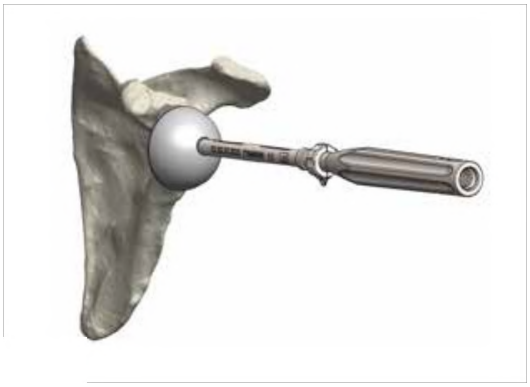


Medacta International

5. IMPLANTACIÓN DE LA GLENOSFERA

PASO 37 | Corrección de la orientación

Si es necesario, corregir la excentricidad con el orientador de glenosfera.



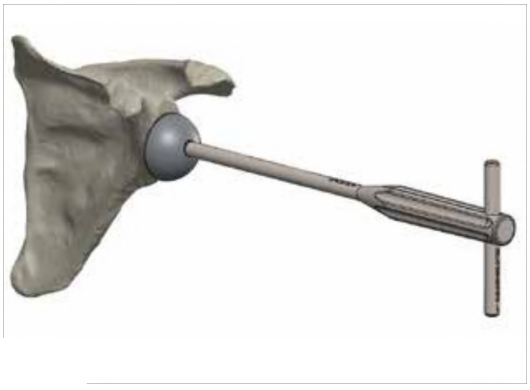
PASO 38 | Impactación inicial

Una vez alineada la excentricidad, impactar suavemente la glenosfera.



PASO 39 | Impactación definitiva

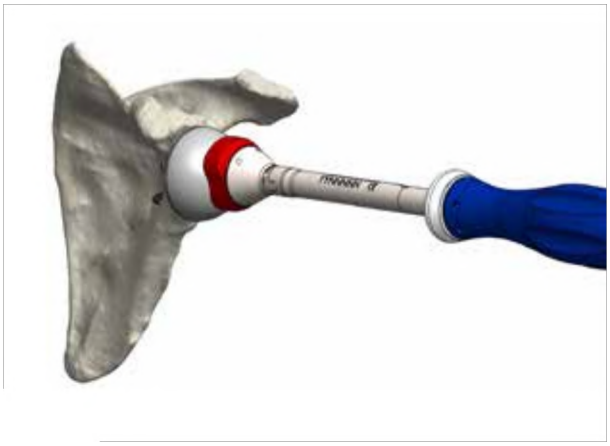
Montar la punta de impactación de glenosfera en el mango multipropósito y completar la impactación.



PASO 40 | Fijación de la glenosfera

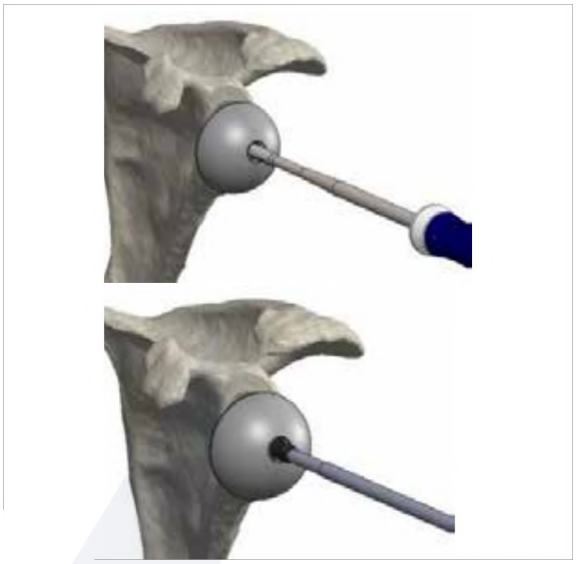
Retirar la guía de glenosfera de la base. Conectar el tornillo a la punta retentiva T15 y apretar con el destornillador limitador de 3 N.m hasta que deslice.

ADVERTENCIA: Retirar la guía antes de colocar el tornillo definitivo.



PASO 41 | Control de la fijación

Verificar que la glenosfera esté completamente asentada y que el tornillo de fijación haya alcanzado el par indicado de 3 N.m.



Medacta International

6. IMPLANTE HUMERAL

PASO 42 | Ensamblaje del vástago reverso

Montar el adaptador de la diáfisis en el bloque de ensamblaje. Insertar la diáfisis y posicionar la metáfisis elegida. Colocar el tornillo metafisario y apretar con el limitador T20 a 6 N.m.

ADVERTENCIA: La marca 155° debe apuntar al cálcar; el pin de indexación debe quedar lateral y dentro de la ranura diafisaria.



PASO 43 | Verificación del ensamblaje

Comprobar cuidadosamente que no exista separación entre metáfisis y diáfisis. Si cuesta liberar el vástago del bloque, usar el dispositivo de extracción de mesa para elevarlo.

ADVERTENCIA: No debe existir espacio entre los dos componentes ensamblados.



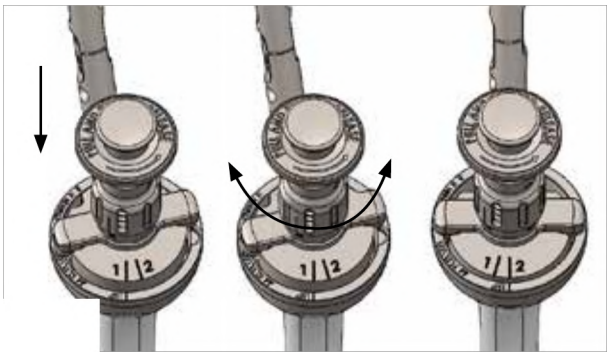
PASO 44 | Conexión del impactor humeral

Deslizar el inserter dentro de la metáfisis reversa y alinear la marca 1 del instrumento con la línea medial del implante.



PASO 45 | Bloqueo del impactor

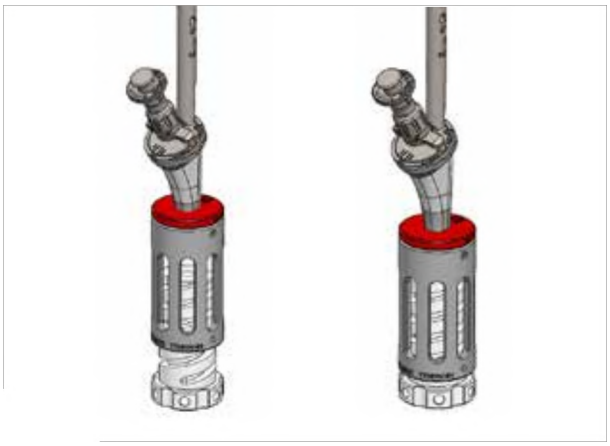
Presionar el mango y girar en sentido horario hasta alinear la marca 2 con la línea medial. El acoplamiento correcto produce un encastre perceptible.



6. IMPLANTE HUMERAL

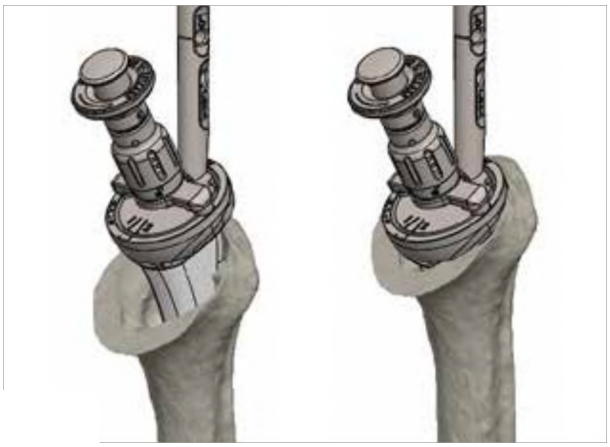
PASO 46 | Impactación del vástago

Golpear suavemente sobre el inserter para fijar el implante dentro del húmero.



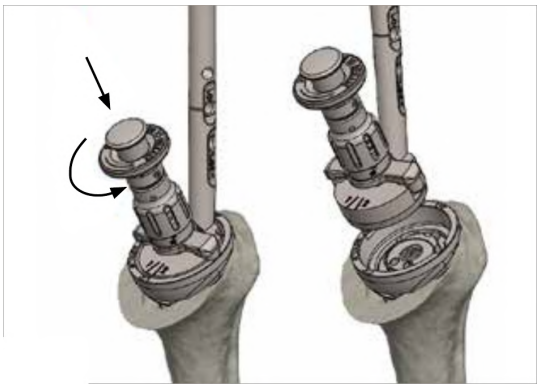
PASO 47 | Control de retroversión

Colocar la varilla en 0° o 20° y alinearla con el antebrazo a 90°. Para retirar el inserter, presionar el mando central, retraer la tapa y girar de la posición 2 a la 1.



PASO 48 | Montaje del impactor del inserto

Conectar la punta de impactación del inserto reverso al mango de impactación.



PASO 49 | Colocación del inserto

Orientar el inserto reverso según la prueba realizada y presentarlo sobre la metáfisis.



PASO 50 | Impactación y control

Impactar el inserto hasta su asiento completo. Reducir la articulación y comprobar estabilidad, movilidad y ausencia de separación entre inserto y metáfisis.



7. RETIRADA Y REVISIÓN

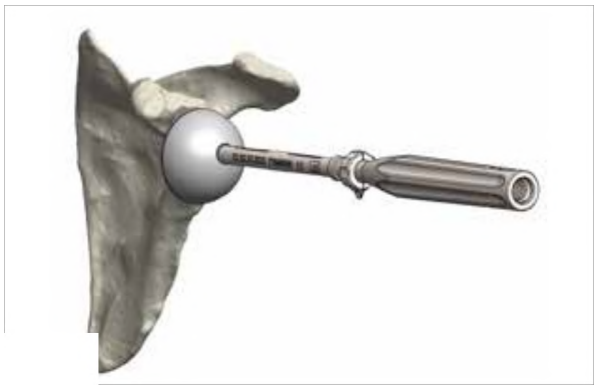
PASO 51 | Aflojamiento del tornillo glenosférico

Aflojar el tornillo de la glenosfera con el destornillador limitador T15 de 3 N.m.



PASO 52 | Dispositivo de extracción

Enroscar el dispositivo de retirada en la glenosfera.



PASO 53 | Extracción de la glenosfera

Enroscar el tornillo de extracción dentro del dispositivo y girarlo hasta desacoplar la glenosfera de la base.



PASO 54 | Desbloqueo del tornillo poliaxial

Desbloquear el tornillo interno con el destornillador limitador modular de 2 N.m y la punta T10 de conexión AO pequeña.



PASO 55 | Retirada del tornillo poliaxial

Utilizar el destornillador poliaxial no retentivo para desenroscar el tornillo bloqueado del hueso y de la base.



7. RETIRADA Y REVISIÓN

PASO 56 | Retirada del tornillo no bloqueado

Usar el destornillador T15 para desenroscar el tornillo no bloqueado del hueso y de la base glenoidea.



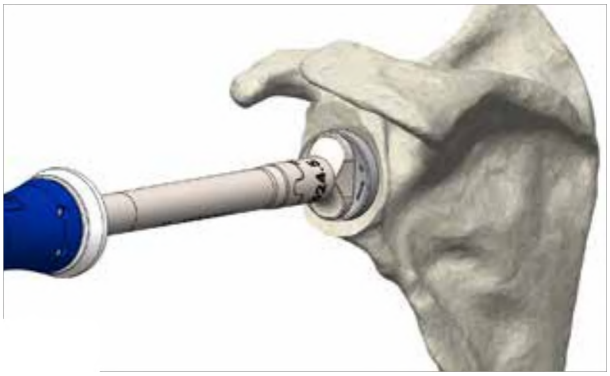
PASO 57 | Montaje del extractor de la base

Montar el mango de impactación, la varilla M5 y la punta del mismo diámetro que la base implantada.



PASO 58 | Extracción de la base glenoidea

Enroscar la varilla M5 en la base. Golpear suavemente la parte inferior del mango y girarlo de forma controlada para retirar la base del hueso.



PASO 59 | Extracción del inserto reverso

Colocar un cincel en la interfaz indicada y golpear en la dirección de la flecha para separar el inserto de la metáfisis reversa.



PASO 60 | Montaje del extractor metafisario

Introducir el tornillo M8 en el posicionador, alinear sus pines con los orificios de la metáfisis y fijarlo. Aflojar el tornillo metafisario con el limitador T20 de 6 N.m mientras se aplica contrapar con el posicionador.



7. RETIRADA Y REVISIÓN

PASO 61 | Retirada del tornillo metafisario

Retirar completamente el tornillo de la metáfisis antes de continuar.



PASO 62 | Montaje del extractor metafisario

Enroscar el extractor de metáfisis reversa/doble excéntrica en el orificio roscado e introducir el tornillo de extracción.



PASO 63 | Separación de metáfisis y diáfisis

Girar el tornillo de extracción hasta desacoplar por completo la metáfisis reversa de la diáfisis.



PASO 64 | Reposicionador diafisario

Conectar el reposicionador de vástago humeral de diseño delgado a la diáfisis y fijarlo con el destornillador HEX 3.5.



PASO 65 | Extracción de la diáfisis

Golpear de forma controlada sobre el punzón del reposicionador hasta extraer la diáfisis del canal humeral.

8. NOMENCLATURA DE IMPLANTES E INSTRUMENTOS

DIÁFISIS HUMERAL CORTA SIN CEMENTO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN
04.01.0179	Diáfisis humeral corta sin cemento - tamaño 6	
04.01.0180	Diáfisis humeral corta sin cemento - tamaño 7	
04.01.0181	Diáfisis humeral corta sin cemento - tamaño 8	
04.01.0182	Diáfisis humeral corta sin cemento - tamaño 9	
04.01.0183	Diáfisis humeral corta sin cemento - tamaño 10	
04.01.0184	Diáfisis humeral corta sin cemento - tamaño 11	
04.01.0185	Diáfisis humeral corta sin cemento - tamaño 12	
04.01.0186	Diáfisis humeral corta sin cemento - tamaño 13	
04.01.0187	Diáfisis humeral corta sin cemento - tamaño 14	
04.01.0188	Diáfisis humeral corta sin cemento - tamaño 15	
04.01.0189	Diáfisis humeral corta sin cemento - tamaño 16	

METÁFISIS HUMERAL REVERSA

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN
04.01.0110	Metáfisis humeral reversa +0 mm/0°	
04.01.0111	Metáfisis humeral reversa +9 mm/0°	
04.01.0112	Metáfisis humeral reversa +0 mm/+20° izquierda	Bajo pedido
04.01.0113	Metáfisis humeral reversa +9 mm/+20° izquierda	Bajo pedido
04.01.0114	Metáfisis humeral reversa +0 mm/+20° derecha	Bajo pedido
04.01.0115	Metáfisis humeral reversa +9 mm/+20° derecha	Bajo pedido

Medacta International

8. NOMENCLATURA DE IMPLANTES E INSTRUMENTOS

INSERTOS HUMERALES REVERSOS HCPE

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN
04.01.0116	Inserto humeral reverso HCPE Ø32/+0 mm	Bajo pedido
04.01.0117	Inserto humeral reverso HCPE Ø32/+3 mm	Bajo pedido
04.01.0118	Inserto humeral reverso HCPE Ø32/+6 mm	Bajo pedido
04.01.0119	Inserto humeral reverso HCPE Ø36/+0 mm	
04.01.0120	Inserto humeral reverso HCPE Ø36/+3 mm	
04.01.0121	Inserto humeral reverso HCPE Ø36/+6 mm	
04.01.0122	Inserto humeral reverso HCPE Ø39/+0 mm	
04.01.0123	Inserto humeral reverso HCPE Ø39/+3 mm	
04.01.0124	Inserto humeral reverso HCPE Ø39/+6 mm	
04.01.0125	Inserto humeral reverso HCPE Ø42/+0 mm	
04.01.0126	Inserto humeral reverso HCPE Ø42/+3 mm	
04.01.0127	Inserto humeral reverso HCPE Ø42/+6 mm	

Los implantes de UHMWPE deben almacenarse al menos 3 horas a 20 °C (±3 °C) antes de la intervención.

BASES GLENOIDEAS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN
04.01.0148	Base glenoidea Ø22 x 15 mm	Bajo pedido
04.01.0149	Base glenoidea Ø22 x 25 mm	Bajo pedido
04.01.0150	Base glenoidea Ø22 x 35 mm	Bajo pedido
04.01.0151	Base glenoidea Ø24.5 x 15 mm	
04.01.0152	Base glenoidea Ø24.5 x 25 mm	
04.01.0153	Base glenoidea Ø24.5 x 35 mm	
04.01.0154	Base glenoidea Ø27 x 15 mm	
04.01.0155	Base glenoidea Ø27 x 25 mm	
04.01.0156	Base glenoidea Ø27 x 35 mm	

Medacta International

8. NOMENCLATURA DE IMPLANTES E INSTRUMENTOS

TORNILLOS GLENOIDEOS POLIAXIALES

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN
04.01.0157	Tornillo glenoideo poliaxial bloqueado - L14	
04.01.0158	Tornillo glenoideo poliaxial bloqueado - L18	
04.01.0159	Tornillo glenoideo poliaxial bloqueado - L22	
04.01.0160	Tornillo glenoideo poliaxial bloqueado - L26	
04.01.0161	Tornillo glenoideo poliaxial bloqueado - L30	
04.01.0162	Tornillo glenoideo poliaxial bloqueado - L34	
04.01.0163	Tornillo glenoideo poliaxial bloqueado - L38	
04.01.0164	Tornillo glenoideo poliaxial bloqueado - L42	
04.01.0165	Tornillo glenoideo poliaxial bloqueado - L46	
04.01.0166	Tornillo glenoideo poliaxial bloqueado - L50	
04.01.0194	Tornillo glenoideo poliaxial no bloqueado - L14	
04.01.0195	Tornillo glenoideo poliaxial no bloqueado - L18	
04.01.0196	Tornillo glenoideo poliaxial no bloqueado - L22	
04.01.0197	Tornillo glenoideo poliaxial no bloqueado - L26	
04.01.0198	Tornillo glenoideo poliaxial no bloqueado - L30	
04.01.0199	Tornillo glenoideo poliaxial no bloqueado - L34	
04.01.0200	Tornillo glenoideo poliaxial no bloqueado - L38	
04.01.0201	Tornillo glenoideo poliaxial no bloqueado - L42	
04.01.0202	Tornillo glenoideo poliaxial no bloqueado - L46	
04.01.0203	Tornillo glenoideo poliaxial no bloqueado - L50	

GLENOSFERAS ESTÁNDAR

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN
04.01.0167	Glenosfera 32 x Ø22	Bajo pedido
04.01.0168	Glenosfera 36 x Ø22	Bajo pedido
04.01.0178	Glenosfera 32 x Ø24,5	Bajo pedido
04.01.0169	Glenosfera 36 x Ø24,5	
04.01.0170	Glenosfera 39 x Ø24,5	
04.01.0171	Glenosfera 42 x Ø24,5	
04.01.0172	Glenosfera 36 x Ø27	
04.01.0173	Glenosfera 39 x Ø27	
04.01.0174	Glenosfera 42 x Ø27	

Medacta International

8. NOMENCLATURA DE IMPLANTES E INSTRUMENTOS

GLENOSFERAS LATERALIZADAS, TORNILLOS E INSTRUMENTAL

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN
04.01.0204	Glenosfera lateralizada 32 x Ø22	Bajo pedido
04.01.0205	Glenosfera lateralizada 36 x Ø22	Bajo pedido
04.01.0206	Glenosfera lateralizada 32 x Ø24,5	Bajo pedido
04.01.0207	Glenosfera lateralizada 36 x Ø24,5	
04.01.0208	Glenosfera lateralizada 39 x Ø24,5	
04.01.0209	Glenosfera lateralizada 42 x Ø24,5	Bajo pedido
04.01.0210	Glenosfera lateralizada 36 x Ø27	
04.01.0211	Glenosfera lateralizada 39 x Ø27	
04.01.0212	Glenosfera lateralizada 42 x Ø27	Bajo pedido
04.01.0176	Tornillo de metáfisis reversa	
04.01.0177	Tornillo de glenosfera	
04.01S.310	Juego general de instrumental de hombro	
04.01S.312	Juego de instrumental para hombro reverso	
04.01S.314	Juego de instrumental para húmero corto	

Los juegos incluyen instrumental motorizado con conexión AO. Las variantes US 04.01S.310 y 04.01S.314 usan conexión Zimmer-Hall.

Medacta International

9. COMPATIBILIDAD Y CODIFICACIÓN

Las matrices indican las combinaciones disponibles entre el diámetro de la base glenoidea y el diámetro de la glenosfera.

GLENOSFERAS ESTÁNDAR	Ø 32	Ø 36	Ø 39	Ø 42
Base Ø 22	SÍ	SÍ	-	-
Base Ø 24,5	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Base Ø 27	-	SÍ	SÍ	SÍ

GLENOSFERAS LATERALIZADAS	Ø 32	Ø 36	Ø 39	Ø 42
Base Ø 22	SÍ	SÍ	-	-
Base Ø 24,5	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Base Ø 27	-	SÍ	SÍ	SÍ

10. CODIFICACIÓN POR COLORES DEL INSTRUMENTAL

HUMERAL — Etiqueta amarillo en el instrumental humeral dedicado.

GLENOIDEO — Etiqueta rojo en el instrumental glenoideo dedicado.

GENERAL — Etiqueta blanco en el instrumental multipropósito.

Excepción: los destornilladores limitadores de par no siguen esta codificación.

NOTAS

ESTERILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN

INSTRUMENTAL

El instrumental se entrega no estéril. Debe limpiarse antes de su uso y esterilizarse en autoclave conforme a la normativa aplicable y a las instrucciones de uso del fabricante del autoclave. Para limpieza, descontaminación y esterilización, consultar las instrucciones vigentes del fabricante de los dispositivos ortopédicos. Las referencias de producto pueden estar sujetas a cambios.

IMPLANTES DE POLIETILENO

Los componentes de UHMWPE deben mantenerse al menos 3 horas a 20 °C (±3 °C) antes de la intervención.

CONTROL PREVIO AL USO

- Confirmar integridad del envase, identificación y fecha de vencimiento de cada implante.
- Verificar que los instrumentos estén completos, limpios, funcionales y compatibles con los componentes planificados.
- Corroborar tamaños, glenosferas, bases, tornillos, insertos y alternativas de revisión antes de iniciar el procedimiento.
- Aplicar siempre las instrucciones de uso vigentes del fabricante y la normativa sanitaria local.

Medacta International

AVISO PROFESIONAL

USO EXCLUSIVO DE PROFESIONALES DE LA SALUD

Este documento es una traducción y recreación editorial de una técnica quirúrgica de referencia. No sustituye la capacitación específica, el juicio clínico del cirujano, las instrucciones de uso vigentes ni las disposiciones regulatorias aplicables. La indicación, selección de componentes, abordaje y técnica final son responsabilidad del equipo tratante.

CHACO IMPLANTES

Corrientes 781, Resistencia, Chaco (3500), Argentina

Tel.: 0362-4571854

chacoimplantes@gmail.com

@chacoimplanteok

Medacta International

Medacta International

DISTRIBUIDO POR

CHACO IMPLANTES
al servicio de la salud

CHACO IMPLANTES

Corrientes 781, Resistencia, Chaco (3500), Argentina

Tel.: 0362-4571854

chacoimplantes@gmail.com

Instagram: @chacoimplanteok

Distribuido por CHACO IMPLANTES

Material destinado exclusivamente a profesionales de la salud. Esta técnica quirúrgica no sustituye las instrucciones de uso vigentes ni el criterio clínico del cirujano.

TRAZABILIDAD DEL DOCUMENTO

DOCUMENTO DE REFERENCIA: Reverse Shoulder System - Short Stem - Surgical Technique

REFERENCIA: 99.81S.12 | REVISIÓN: 06 | ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: Julio de 2020

FABRICANTE: Medacta International SA